

Fecha Última Actualización: 04-01-2026 15:15:08

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Damaso Angulo San Martín
Edad : 66a 0m 24d
Dirección : Orilla Del Rio 166-A El Principal

Rut : 8.153.597-3
Fecha Nacto: 11/12/1959
Comuna : Pirque

N° Archivo : 1830530
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 9807 4498

N° Epicrisis
467630

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 29/12/2025 06:05

Días Estadía: 6

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 04/01/2026 15:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

compromiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Damaso Angulo San Martin
Rut: 8153597-3
Edad: 66 años

ANTECEDENTES

- Mórbidos: LLA B común CD20 (+) y Phi (+) en fase mantención (debut 2022 con QT LLA > 60 años + Dasatinib + QT intratecal), Raquiestenosis lumbar
- Quirúrgicos: Hernia lumbar, Colectomía, Prótesis dental superior
- Medicamentos: Metotrexato 20mg/sem, Dasatinib 100mg/d, Mercaptopurina 100mg/d, Cotrimoxazol F trisemanal (Lu-Mi-Vi), Omeprazol 20mg/d, Pregabalina 75mg/d, Paracetamol-Tramadol SOS, Celecoxib SOS.
- Alergias: No refiere
- Hábitos: Tabaquismo (-), Alcohol (-), Drogas (-)
- Hospitalización reciente: Enero/2025 ingreso electivo para vincristina + QT intratecal.
- Social: Vive con esposa, trabaja en reparación de máquinas, independiente para ABVD.

HISTORIA ONCOLÓGICA

- 16 Nov 2022: Sd. Consuntivo + epistaxis, bicitopenia e hiperleucocitosis (GB 454.000). oMielograma con CMF para 97% blastos estirpe linfóide B sugerente de LLA B común. oCitogenética 46,XY,t(9;22)(q34;q11.2)[8]/46,XY,der(9)del(9)(p21)t(9;22)(q34;q11.2)[14]/46,XY oBiología molecular BCR/ABL 1(+) p210
- 30 Nov 2022: QT protocolo LLA > 60 años con Dasatinib + QT intratecal semanal.
- 01 Dic 2022: QT mantención con Metotrexato + Mercaptopurina + Dasatinib.
- 31 Ene 2025: Mantuvo POMP 21 meses.
- 09 Jun 2025: Mielograma en remisión completa y hemograma normal. Control 3 meses.

MC: Compromiso de conciencia

ANAMNESIS

Paciente con antecedentes descritos, cursa cuadro de 4 días de evolución caracterizado por vómitos y compromiso del estado general. Progresó con compromiso de conciencia cuali-cuantitativo asociado a episodio convulsivo presenciado por familiares

Fecha Epicrisis : 04/01/2026 15:15

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 04-01-2026 15:15:08

Página 2 de 3

(movimientos repetitivos, pérdida de control de esfínter) y diplopía. Al interrogatorio dirigido niega sangrado, disnea, dolor torácico, dolor abdominal, diarrea, aumento de volumen y sin otros síntomas.

Ingresó al servicio de urgencia hipertenso (151/76), normocardico (75), afebril (36), y sin requerimientos de oxígeno (Sat 94% ambiental). Al examen físico en sopor, deshidratado, moviliza 4 extremidades y buena perfusión periférica.

-Laboratorio de inicio destaca hiperleucocitosis hasta 435.000 con predominio linfocítico, bicitopenia con anemia severa normocítica (Hb 5.8, VCM 84) y trombocitopenia severa (35.000), hiperuricemia (7.8 mg/dL), LDH alta (1833), PCR baja (12.2). Sin falla renal, potasio y calcio normal.

-TC cerebro sin contraste (28/12), sin informe se observa hemorragia intraparenquimatosa bifrontal.

-TC TAP sin contraste (28/12) con foco condensación basal derecho y componente atelectásico.

Durante estadía en urgencia evaluado por neurocirugía quienes desestiman intervención quirúrgica. Recibió anticonvulsivantes (Fenitoína, NP 21), hemoderivados (GR 2 UGR, 3 UPLQ por stock disponible), antibióticos (Ampicilina/Sulbactam) y volemicización (SF0.9% a 100 cc/h). Evoluciona con mayor deterioro neurológico, por lo que se decide manejo avanzado de vía aérea.

Secuencia de intubación rápida, cormack 2, uso de Fentanilo + Propofol + Rocuronio, intubación 1° intento, tubo #7.5 a 23cm de comisura labial. Sedación con fentanilo + propol para SAS 1. Se traslada a UPC para manejo y monitorización neurocrítico.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

Sd. Hiperviscosidad por aumento glóbulos blancos

-Crisis blástica LLA

-ACV hemorrágico (ICH 2 ptos)

oHemorragia intraparenquimatosa bifrontal

Insuficiencia respiratoria aguda

-Neumonía aspirativa

-IOT 28/12

Antecedentes: LLA B común, Raquiestenosis lumbar

Evolución en UCI:

Hemodinamia: desde su ingreso sin requerimientos de DVA. con hipertensión permisiva en contexto de hemorragia cerebral. Volemización abundante por hiperviscosidad y lisis, con transfusión de hemoderivados dado bicitopenia severa. Se inicia terapia antihipertensiva evitando hemorragia sobreagregada. Tras deterioro neurológico secundario a edema cerebral difuso evoluciona con tendencia a la hipotensión. Por pronóstico ominoso se decide no inicio de DVA.

Respiratorio: Compromiso de conciencia con necesidad de protección de vía aérea. Sin conflicto de intercambio gasométrico pero sin posibilidad de weaning dado condición neurológica.

Hematología: Ant. LLA B común, CD20 (+) y Phi (+), mantuvo controles con hematología (Dr. Viñuela) en remisión completa, terminó tratamiento en Jun/2025. Cursando Sd. Hiperviscosidad con evento hemorrágico mayor, inicio corticoides (dexametasona 4mg c/12h) y volemicización (3000 cc/d). Conversado verbalmente con Hematología quienes sugieren Dasatinib 70mg c/12h. Además, prevención de lisis tumoral con alopurinol. Requirió transfusión de GR y plaquetas en contexto de anemia severa y sangrado intracerebral.

Neurología: Ant. ACV hemorrágico en 2022 con RM cerebro (21/11/2022) que informó incontables lesiones hemorrágicas (y microhemorrágicas) supra e infratentoriales de distribución difusa. Ingresó con nuevo evento hemorrágico con HIP bifrontal. Evaluado por neurocirugía quienes desestiman indicación quirúrgica, indican carga de fenitoína sin mantención y sugieren disminuir sedación para evaluar despertar. Evaluado por neurología UPC quienes solicitan EEG e inician Levetiracetam. El 02/12 con quiebre clínico y aparición de midriasis bilateral. Se realiza nuevo TAC de cerebro que evidencia múltiples lesiones hemorrágicas, bifrontales, temporales, cerebelosas y en tronco encefálico. Obliteración de las cisternas basales, colapso del sistema ventricular. Lesiones hipodensas difusas. Evaluado por neurocx se constata paciente fuera de alcance terapéutico, sin indicación quirúrgica. Se sugiere proporcionalizar medidas. Paciente evoluciona con poliuria severa e hipernatremia severa, con requerimientos de desmopresina. Se inicia terapia hiposomolar. Se conversa con familiares y explica pronóstico ominoso de paciente. Se decide limitación de medidas y esfuerzo terapéutico. Paciente cursa con hipertensión intracraneana severa sin respuesta a manejo médico. Fallece el 04/01/26, a las 11:25 AM en compañía de familiares.

Infeccioso: Neumonía aspirativa sin neutropenia, se inicia Ampicilina/Sulbactam. PCR estacionaria (53 -> 57). Hemocultivos del 29/12 negativos. Sin CAET.

Diagnóstico de Egreso

Fecha Epicrisis : 04/01/2026 15:15

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 04-01-2026 15:15:08

Página 3 de 3

ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMICO - Síndrome hipertensión endocraneana
Leucemia Linfoblástica Aguda - Síndrome de hiperviscosidad

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J: NO

Fallecido

Plan Post Alta

traslado anatomía patológica

Indicaciones

Tipo de Reposo :

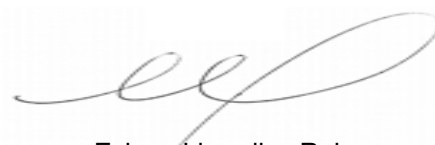
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Eyleen Llewellyn Rojo

Médico Tratante (Staff)